

PROTOCOLO DE CELULITIS BACTERIANA EN UOME

Unidad de Observación de Media Estancia (UOME)
Versión de trabajo para revisión multidisciplinar

1. OBJETIVO

Establecer un protocolo de actuación para pacientes diagnosticados en Urgencias de celulitis bacteriana no necrotizante susceptibles de manejo en UOME mediante antibioterapia intravenosa inicial, monitorización clínica y reevaluación precoz, favoreciendo el alta segura o la derivación al recurso asistencial más adecuado.

2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Necesidad de antibioterapia intravenosa inicial pro fracaso de tratamiento oral.
- Necesidad de monitorización de extensión de la lesión cutánea las primeras 24 horas.
- Celulitis extensa o con edema importante.
- Afectación moderada-grave. Ausencia de sepsis-shock séptico.
- Ausencia de sospecha de fascitis necrotizante
- Dudas sobre la adherencia terapéutica o soporte social deficient a nivel domiciliario.
- Previsible estabilidad clínica y alta ≤ 36 horas.

3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN / INGRESO DIRECTO

- Sospecha de fascitis necrotizante (dolor desproporcionado, crepitación, ampollas hemorrágicas, equimosis o anestesia local).
- Absceso profundo que precise drenaje.
- Osteomielitis.
- Infección protésica.
- Sepsis o shock séptico.
- Lactato elevado persistente.
- Neutropenia, inmunosupresión grave.
- ERC estadio IV-V.
- Cirrosis avanzada.
- Fragilidad severa.
- Factores de riesgo de MRSA o multirresistencias que requieran antibioterapia compleja.

4. EVALUACIÓN INICIAL

Constantes: TA, FC, FR, SatO₂ y temperatura.

Analítica: hemograma, bioquímica con función renal, iones, PCR, y coagulación.

Valorar lactato, procalcitonina y hemocultivos si fiebre $>38,5$ °C, sospecha de bacteriemia o inmunosupresión.

Cultivo de exudado de herida/puerta de entrada visible con supuración.

Comprobar correcta vacunación de **TÉTANOS**

5. CONTROL EVOLUTIVO

Constantes cada **4 horas** durante las **primeras 12 horas**.

Posteriormente cada **6-8 horas** si estabilidad.

Reevaluación médica a las 6-8 horas y a las 24 horas:

- Signos inflamatorios: Dolor, extensión del eritema, y fiebre.
- Respuesta clínica.
- Necesidad de pruebas complementarias.
- Valoración de destino.

6. CONTROL ANALÍTICO

Control a las **12-24 horas** si:

- Fiebre persistente.
- PCR y Lactato elevado.
- Leucocitosis importante.
- Insuficiencia renal.
- Fragilidad.

Signos de alarma:

- Signos clínicos y analíticos sugestivos de toxicidad sistémica (sepsis): Incremento de PCR, leucocitosis progresiva, lactato elevado, hipotensión arterial, fiebre persistente, deterioro de función renal...
- Progresión rápida de la lesión a pesar de >24 horas de antibioterapia IV.
- Sospecha de infección necrotizante (dolor desproporcionado, ampollas hemorrágicas, crepitación)

7. PRUEBAS DE IMAGEN

Ecografía de partes blandas:

- Sospecha de absceso, fluctuación a la palpación.
- Mala evolución clínica.

TC urgente:

- Sospecha de fascitis necrotizante.
- Afectación profunda.
- Sospecha de osteomielitis.

8. TRATAMIENTO

Medidas generales:

- Elevación de la extremidad afectada por encima del nivel del corazón para disminuir linfedema
- Hidratación adecuada.
- Delimitar con rotulador permanente el borde de eritema al ingreso, para evaluar objetivamente la progresión o regresión en los cambios de turno.

Analgesia escalonada:

- Paracetamol 1 g IV/VO cada 8 h.
- Metamizol 2 g IV cada 8 h si precisa por dolor o fiebre.
- Dexketoprofeno 50 mg IV cada 8 h si no contraindicación.
- Opiáceos IV si precisa por dolor refractario.

9. ANTIBIOTERAPIA EMPÍRICA

Sospecha de *Streptococcus* o *S.aureus* sensible a meticilina

Primera elección:

- **Cefazolina 2 g IV cada 8 h.**

Alternativas:

- Amoxicilina-clavulánico 1 g IV cada 8 h.
- Ceftriaxona 2 g IV cada 24 h. (+ Metronidazol 500 IV cada 8 horas en ODONTOLÓGICAS)

Alergia a betalactámicos:

- Clindamicina 600 mg IV cada 8 h.

MRSA o multirresistencias:

- Valorar ingreso hospitalario y tratamiento individualizado según PROA.

10. CONTROLES DE ENFERMERÍA

- Constantes según protocolo.
- Registro del dolor (0–10) al menos una vez por turno.
- Respuesta analgésica.
- Vigilancia de tolerancia antibiótica.
- Delimitación y registro del eritema.
- Vigilancia de progresión o regresión.
- Vigilancia de flictenas, necrosis, exudado o fluctuación.
- Elevación de la extremidad afectada.

Signos de alarma:

- Extensión del eritema más allá del marcaje.
- Dolor $\geq 7/10$ o progresivo.
- Fiebre $>38^{\circ}\text{C}$ persistente.
- TAS <100 mmHg.
- FC >110 lpm.
- Deterioro clínico.

11. DESTINO EVOLUTIVO

Alta domiciliaria:

- Estabilidad hemodinámica.

- Mejoría del dolor y edema, y afebril durante un mínimo de 8-12 horas.
- Eritema estable o en regresión.
- Tolerancia oral.

Hospitalización a Domicilio (HAD):

Valorar si precisa continuidad asistencial o antibioterapia IV. La aceptación dependerá de cobertura geográfica, disponibilidad, apoyo domiciliario y criterios propios de HAD.

Hospital Fundación de Avilés (HFA):

Valorar si precisa continuidad asistencial hospitalaria o cuidados intermedios y no es candidato a HAD.

Ingreso en Medicina Interna:

- Mala evolución clínico-analítica.
- Persistencia de fiebre tras 24–36 h.
- Progresión del eritema.
- Sospecha de bacteriemia.
- Necesidad de antibioterapia compleja.

12. ANTIBIOTERAPIA ORAL AL ALTA

- Cefalexina 500 mg VO cada 6 h.
- Cefadroxilo 1 g VO cada 12 h.
- Amoxicilina-clavulánico 875/125 mg VO cada 8 h.
- Clindamicina 300–450 mg VO cada 6–8 h si alergia.

Duración habitual (contando los días de ingreso):

- 5–7 días.
- 10–14 días en evolución lenta o extensa.

13. RECOMENDACIONES AL ALTA

Reconsulta por:

- Fiebre persistente.
- Aumento del dolor.
- Extensión del eritema.
- Fluctuación o supuración.
- Deterioro general.

Mantener antibioterapia, elevación de extremidad e hidratación adecuada.

14. BIBLIOGRAFÍA

IDSA Practice Guidelines for Skin and Soft Tissue Infections.

Eron Classification of Cellulitis.

NICE Guidance on Cellulitis and Erysipelas.

PROA-SEIMC / PRAN.

Guías de Terapéutica Antimicrobiana HUCA.

Protocolos PROA Hospital San Agustín.

UpToDate: Acute Cellulitis and Erysipelas.